

GUIA PRÁTICO DE INÍCIO CLÍNICO

Primeiros Atendimentos

Kit de sobrevivência do psicólogo recém-formado: roteiros, checklists, modelos e orientações para começar com mais segurança, ética e organização.

Uso profissional

Do primeiro contato ao fechamento da sessão

Primeira sessão • anamnese • contrato • evolução • plano terapêutico • faltas • online • marketing ético

Conteúdo do kit

01. Leia antes de usar

limites, ética e responsabilidade

02. Fluxo do primeiro atendimento

antes, durante e depois

03. Roteiro de primeira sessão

estrutura acolhedora e objetiva

04. Modelos de anamnese

adulto, adolescente, criança e responsáveis

05. Contrato e consentimento

modelos adaptáveis

06. Evolução e plano terapêutico

registros, hipóteses e objetivos

07. Sessão travada

silêncio, “não sei” e insegurança

08. Postura profissional

limites, cobrança, faltas e online

09. Marketing ético

perfil, conteúdo e explicação da terapia

10. Organização prática

agenda, financeiro e plano de 30 dias

Leia antes de usar

Material de apoio, não substituição de responsabilidade técnica

Este kit foi criado para apoiar psicólogos em início de carreira na organização dos primeiros atendimentos. Ele não substitui supervisão clínica, estudo contínuo, atualização ética, leitura das normas profissionais aplicáveis ou orientação jurídica/contábil quando necessária.

Modelos de contrato, consentimento e registros devem ser adaptados à realidade do serviço, público atendido, modalidade, abordagem, normas locais e orientações do respectivo Conselho Regional de Psicologia.

Em situações de risco, violência, ideação suicida, automutilação, abuso, negligência ou urgência, priorize protocolos de segurança, rede de apoio, serviços de emergência e supervisão.

Ideia central: segurança profissional não nasce de decorar falas perfeitas. Nasce de ter estrutura, escuta, supervisão, ética e clareza suficiente para conduzir o processo sem improvisar tudo.

Fluxo do primeiro atendimento

Antes

- Confirmar modalidade, horário e valores.
- Enviar informações básicas de funcionamento.
- Preparar ficha, contrato/termo e ambiente.
- Checar se há demanda de urgência.

Durante

- Acolher e explicar como funciona.
- Compreender demanda principal.
- Mapear contexto, história e risco.
- Combinar próximos passos.

Depois

- Registrar evolução.
- Organizar hipótese inicial.
- Definir objetivo provisório.
- Enviar combinados, se necessário.

Checklist pré-atendimento

Item	Conferido?
Horário, modalidade e link/endereço confirmados	
Valor, forma de pagamento e política de faltas explicados	
Contrato/termo preparado para envio ou assinatura	
Ficha inicial/anamnese disponível	
Ambiente reservado, silencioso e com privacidade	
Plano de manejo de risco/urgência conhecido	

Roteiro de primeira sessão

ABERTURA

“Antes de entrarmos na sua história, quero te explicar rapidamente como funciona este espaço. A terapia é um processo de escuta, compreensão e construção de estratégias. Algumas coisas vamos entender juntos ao longo do tempo, então você não precisa chegar com tudo organizado hoje.”

CONTRATO TERAPÊUTICO

Explique duração, frequência, sigilo, limites do sigilo, faltas, remarcações, contato entre sessões, pagamento e forma de registro. Use linguagem simples e confirme se a pessoa entendeu.

DEMANDA INICIAL

“O que fez você procurar atendimento neste momento?”
“O que você gostaria que fosse diferente nos próximos meses?”
“O que está mais difícil de sustentar hoje?”

CONTEXTO E FUNCIONAMENTO

Investigue rotina, sono, alimentação, trabalho/estudo, vínculos, saúde física, histórico de tratamento, uso de medicação/substâncias, rede de apoio e fatores recentes de estresse.

FECHAMENTO

“Do que conversamos hoje, o que parece mais importante para começarmos?”
“Como foi para você falar sobre isso?”
“Para a próxima sessão, podemos aprofundar...”

Modelos de anamnese - como usar sem transformar a sessão em interrogatório

Antes do modelo: anamnese não é checklist mecânico

A anamnese é um mapa inicial. Ela ajuda a compreender demanda, contexto, história, funcionamento atual, fatores de risco, recursos de proteção e objetivos possíveis. Mas ela não precisa ser aplicada de forma rígida, fria ou completa em uma única sessão.

Em muitos casos, especialmente nos primeiros atendimentos, o mais importante é criar vínculo, explicar o processo e organizar as informações essenciais. O restante pode ser aprofundado ao longo das sessões, conforme a pessoa se sentir segura e conforme a demanda clínica exigir.

Use os modelos abaixo como base adaptável. Você pode imprimir, preencher digitalmente ou transformar em roteiro de entrevista. Evite usar todas as perguntas se isso prejudicar a escuta. O objetivo é sustentar a condução clínica, não substituir sua sensibilidade profissional.

Regra prática: comece por segurança, demanda, funcionamento atual e expectativa. Depois avance para história, padrões, vínculos, hipótese clínica e plano terapêutico provisório.

Anamnese inicial - adulto

1. Identificação e dados básicos

Nome completo	
Nome social/pronome, se houver	
Data de nascimento / idade	
Telefone / e-mail	
Profissão, ocupação ou rotina principal	
Cidade / modalidade do atendimento	
Contato de emergência	

2. Demanda principal

O que trouxe a pessoa ao atendimento neste momento? Qual foi o gatilho para buscar ajuda agora, e não antes?

PERGUNTAS ÚTEIS

- O que está mais difícil de sustentar hoje?
- Quando você percebeu que precisava de ajuda?
- O que você espera que mude com a terapia?
- Se a terapia ajudasse, o que estaria diferente na sua vida em alguns meses?

3. História do problema atual

Aspecto	Observações
Quando começou?	
Como evoluiu?	
O que piora?	
O que alivia?	
Já aconteceu antes?	
Como isso interfere na vida?	

Anamnese adulto - funcionamento e contexto

4. Funcionamento atual

Área	Investigar	Observações
Sono	horários, qualidade, insônia, excesso de sono, pesadelos	
Alimentação	apetite, compulsões, restrições, alterações recentes	
Energia	cansaço, disposição, dificuldade de iniciar tarefas	
Humor	tristeza, irritabilidade, ansiedade, apatia, oscilação	
Trabalho/estudo	desempenho, faltas, sobrecarga, conflitos, sentido	
Relacionamentos	família, amizade, parceiro(a), isolamento, apoio	
Lazer e prazer	atividades abandonadas, interesses, descanso real	
Saúde física	diagnósticos, dores, exames, tratamentos, medicação	
Substâncias	álcool, maconha, estimulantes, automedicação, frequência	
Espiritualidade/cultura	fontes de sentido, comunidade, valores importantes	

5. Rede de apoio e fatores de proteção

6. Principais estressores atuais

7. Estratégias que a pessoa já tentou

Anamnese adulto - risco, histórico e objetivos

8. Avaliação inicial de risco

Use esta parte com cuidado, linguagem humana e sem alarmismo. Quando houver ideação suicida, automutilação, violência, negligência, abuso, risco a terceiros ou incapacidade importante de autocuidado, priorize segurança, supervisão, rede de apoio e encaminhamentos necessários.

Ponto de atenção	Sim/Não	Detalhes
Pensamentos de morte ou desaparecimento		
Ideação suicida atual ou recente		
Plano, intenção ou meios disponíveis		
Automutilação atual ou histórico		
Violência doméstica, abuso ou ameaça		
Uso abusivo de álcool/outras substâncias		
Rede de apoio disponível		

9. Histórico de tratamento

Já fez psicoterapia?	
Já fez acompanhamento psiquiátrico?	
Usa ou usou medicação?	
Internações, crises ou atendimentos de urgência?	

10. Objetivos iniciais do processo

11. Hipótese inicial e próximos passos

Anamnese - criança

1. Dados da criança e responsáveis

Nome da criança	
Idade / data de nascimento	
Responsáveis legais	
Quem mora com a criança?	
Escola / série / período	
Contato de emergência	

2. Queixa principal dos responsáveis

3. O que a criança percebe?

Quando possível, investigue com linguagem adequada à idade: o que ela acha difícil, do que gosta, o que a deixa triste, brava, preocupada ou com medo.

4. Contextos em que a dificuldade aparece

Contexto	Como aparece?	Frequência / intensidade
Casa		
Escola		
Família ampliada		
Amizades		
Atividades externas		

Anamnese criança - desenvolvimento, rotina e escola

5. Desenvolvimento e saúde

Área	Observações
Gestação, parto e primeiros meses	
Marcos do desenvolvimento	
Linguagem e comunicação	
Coordenação motora e autonomia	
Histórico médico / exames / medicações	
Sono, alimentação e desfralde	
Sensibilidades sensoriais	

6. Rotina e comportamento

Aspecto	Observações
Manhã / tarde / noite	
Uso de telas	
Brincadeiras e interesses	
Regras, limites e combinados	
Crises, birras ou explosões emocionais	
Medos, ansiedade ou evitação	
Habilidades sociais	

7. Escola

8. Objetivos iniciais dos responsáveis

Anamnese - adolescente

Confidencialidade precisa ser explicada com clareza

Com adolescentes, é importante explicar o sigilo de forma adequada: existe um espaço de privacidade, mas situações de risco, violência, abuso, automutilação, ideação suicida ou ameaça à segurança exigem cuidado responsável e, quando necessário, envolvimento dos responsáveis ou rede de proteção.

1. Dados iniciais

Nome / idade	
Responsáveis	
Escola / série	
Quem solicitou o atendimento?	

2. Demanda do adolescente

3. Demanda dos responsáveis

4. Funcionamento atual

Área	Observações
Humor e ansiedade	
Sono e energia	
Escola e desempenho	
Amizades e pertencimento	
Família e conflitos	
Imagem corporal e autoestima	
Uso de telas e redes sociais	
Substâncias e comportamentos de risco	

5. Risco e proteção

6. Objetivos iniciais combinados

Anamnese - responsáveis e orientação parental

1. Composição familiar e rotina

Ponto	Observações
Quem mora na casa?	
Como é a rotina em dias úteis?	
Como é a rotina em fins de semana?	
Quem participa dos cuidados?	
Há separação, guarda compartilhada ou conflitos familiares?	

2. Práticas educativas

Área	Observações
Regras e limites	
Como lidam com birras/crises?	
Como recompensam comportamentos positivos?	
Quais combinados funcionam?	
Quais situações mais desgastam?	

3. Expectativas dos responsáveis

4. Orientações iniciais possíveis

Anamnese - casal ou relacionamento

Este modelo é útil quando a demanda envolve casal, relacionamento amoroso ou conflitos relacionais recorrentes. Adapte de acordo com sua formação, abordagem e possibilidade técnica de atender esse tipo de demanda.

1. Dados e contexto

Nomes e idades	
Tempo de relacionamento	
Moram juntos?	
Filhos ou dependentes?	
Quem buscou atendimento?	

2. Demanda principal

3. Ciclos de conflito

Ponto	Observações
Quais temas se repetem?	
Como geralmente começa uma discussão?	
O que cada um faz quando se sente ameaçado?	
Como tentam reparar?	
Há violência, coerção, medo ou controle?	

4. Objetivos e limites do atendimento

Modelo de contrato terapêutico adaptável

Use como base, não como documento automático

Este modelo foi criado para ajudar o psicólogo recém-formado a organizar os combinados essenciais do atendimento. Ele precisa ser revisado e adaptado à realidade profissional, modalidade de atendimento, público atendido, políticas de pagamento, normas do Conselho Regional de Psicologia, obrigações de registro e orientações jurídicas/contábeis quando necessário.

O contrato terapêutico não deve ser apresentado como barreira fria ou burocrática. Ele pode ser explicado como uma forma de proteger o processo, alinhar expectativas e reduzir ruídos sobre horário, pagamento, faltas, sigilo e comunicação.

“Antes de começarmos, vou te explicar os combinados do atendimento. Eles existem para deixar o processo mais claro e seguro para nós dois: frequência, duração, valores, faltas, sigilo, contato entre sessões e situações em que posso precisar acionar suporte por segurança.”

Boa prática: evite entregar contrato sem explicar. Leia os pontos principais com a pessoa e verifique se ela compreendeu, especialmente sigilo, limites do sigilo, faltas e contato entre sessões.

Contrato terapêutico - estrutura completa

1. Identificação das partes

Profissional: nome completo, CRP, CPF/CNPJ se aplicável, e-mail profissional, telefone profissional e endereço profissional ou indicação de atendimento online.

Cliente/paciente: nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail e endereço. Em caso de menor de idade, incluir dados do responsável legal e grau de parentesco.

2. Objeto do atendimento

O presente instrumento tem como objetivo estabelecer os combinados referentes à prestação de serviços psicológicos, incluindo modalidade, frequência, duração, honorários, política de faltas, sigilo profissional, limites de comunicação e condições gerais do processo.

O acompanhamento psicológico não configura promessa de resultado, cura ou garantia de mudança específica. Trata-se de um processo técnico, colaborativo e gradual, conduzido de acordo com princípios éticos e científicos da Psicologia.

3. Modalidade, frequência e duração

As sessões serão realizadas na modalidade _____, com duração aproximada de _____ minutos, frequência _____ e horário previamente combinado entre as partes.

Alterações de horário, frequência ou modalidade poderão ser feitas mediante acordo prévio, considerando disponibilidade profissional, necessidade clínica e condições do serviço.

Contrato terapêutico - honorários, faltas e comunicação

4. Honorários e forma de pagamento

O valor acordado por sessão será de R\$ _____. O pagamento será realizado por _____, preferencialmente até _____.

Quando houver emissão de recibo, nota fiscal ou comprovante, a forma de envio e os dados necessários deverão ser combinados previamente.

Reajustes de honorários, quando aplicáveis, deverão ser comunicados com antecedência e acordados de forma clara.

5. Faltas, atrasos e remarcações

Remarcações deverão ser solicitadas com antecedência mínima de _____ horas. Faltas sem aviso dentro do prazo poderão ser cobradas, conforme combinado no início do processo.

Atrasos do paciente não necessariamente estendem o horário da sessão, pois podem comprometer atendimentos posteriores. Atrasos do profissional deverão ser compensados ou reorganizados de forma ética e transparente.

Em situações excepcionais, como emergências, adoecimento ou imprevistos graves, as partes poderão conversar sobre a melhor forma de manejar a ausência.

6. Comunicação entre sessões

O canal de comunicação profissional será _____. Esse canal poderá ser usado para confirmações, reagendamentos e informações objetivas sobre o atendimento.

Mensagens entre sessões não substituem atendimento psicológico, intervenção de crise ou serviço de emergência. O tempo de resposta pode variar conforme agenda profissional e horário de funcionamento.

Contrato terapêutico - sigilo, registros e segurança

7. Sigilo profissional

As informações compartilhadas em atendimento são protegidas por sigilo profissional, conforme princípios éticos da Psicologia. O sigilo é uma condição essencial para segurança, confiança e qualidade do processo.

Existem situações em que o sigilo pode ter limites, especialmente quando houver risco relevante à vida, à integridade física ou psicológica da pessoa atendida ou de terceiros, suspeita de violência, abuso, negligência, violação de direitos ou determinação legal aplicável. Nesses casos, o profissional deverá agir com responsabilidade técnica, buscando proteção, encaminhamento e orientação adequada.

8. Registros e prontuário

O profissional realizará registros técnicos do acompanhamento, respeitando a finalidade clínica, ética e documental do processo. Esses registros devem ser armazenados com cuidado, privacidade e segurança.

Quando houver solicitação de documentos psicológicos, relatórios, declarações ou encaminhamentos, a elaboração dependerá de avaliação técnica, finalidade adequada e respeito às normas profissionais vigentes.

9. Situações de urgência e risco

O atendimento psicológico regular não funciona como serviço de emergência 24 horas. Em situações de risco imediato, ideação suicida com plano/intenção, automutilação grave, violência ou emergência médica, a pessoa deverá procurar serviço de urgência, rede de apoio ou contato de emergência disponível na região.

Contrato terapêutico - atendimento online, encerramento e assinatura

10. Atendimento online

Quando o atendimento ocorrer online, a pessoa atendida se compromete a buscar local reservado, com privacidade, conexão adequada e segurança mínima para a sessão. O profissional também deverá preservar ambiente sigiloso e adequado.

Em caso de queda de conexão, as partes poderão tentar reconectar por até _____ minutos. Persistindo o problema, será combinada a melhor forma de remarcação ou continuidade, conforme contexto.

11. Encerramento, interrupção e encaminhamento

O processo poderá ser encerrado por alta, acordo entre as partes, desistência do paciente, impossibilidade de continuidade ou necessidade de encaminhamento. Sempre que possível, recomenda-se uma sessão de fechamento para revisão do processo, próximos passos e orientações finais.

O profissional poderá indicar encaminhamento quando a demanda ultrapassar sua competência técnica, exigir avaliação médica/psiquiátrica, envolver risco ou demandar serviço especializado.

12. Ciência e assinatura

Declaro que li, compreendi e concordo com os principais combinados deste atendimento, incluindo modalidade, honorários, faltas, sigilo, limites do sigilo, comunicação e condições gerais do processo.

Assinatura do(a) paciente ou responsável legal

Assinatura do(a) psicólogo(a)

Local e data: _____

Termo de consentimento - estrutura adaptável

O que deve ficar claro

- Finalidade do atendimento psicológico.
- Sigilo e seus limites.
- Forma de registro e guarda de informações.
- Possibilidade de encaminhamento quando necessário.
- Condições do atendimento online, quando houver.
- Direitos, deveres e canais de contato.

Texto-base

Declaro que fui informado(a) sobre a natureza do atendimento psicológico, seus objetivos gerais, condições de funcionamento, limites do sigilo profissional e possibilidade de encaminhamento ou contato com rede de apoio/serviços quando houver risco ou necessidade de proteção.

Em atendimento online, declaro compreender a importância de estar em ambiente reservado, com conexão adequada e condições mínimas de privacidade.

Nome: _____ Data: ____/____/____ Assinatura:

Modelos de evolução de sessão

Modelo simples

Data:

Demanda da sessão:

Temas trabalhados:

Intervenções realizadas:

Resposta/observações:

Plano para próxima sessão:

Modelo SOAP

S - Subjetivo: relato do paciente.

O - Objetivo: observações relevantes.

A - Avaliação: compreensão clínica provisória.

P - Plano: próximos passos.

Plano terapêutico inicial

Elemento	Registro
Demanda principal	
Hipóteses iniciais	
Objetivos do processo	
Recursos/pontos fortes	
Fatores de risco/proteção	
Intervenções iniciais	
Critérios de progresso	

Quando a sessão trava

SILÊNCIO

“Podemos ficar alguns segundos com isso. Não precisa responder rápido.”

NÃO SEI

“Tudo bem não saber. O que você sabe que não é?”

RACIONALIZAÇÃO

“O que sua explicação ajuda a entender, e o que ainda continua doendo?”

EMOÇÃO EVITADA

“Qual emoção seria mais difícil admitir nessa situação?”

EXCESSO DE ASSUNTO

“De tudo isso, qual parte pede cuidado primeiro?”

FECHAMENTO

“Qual é a menor coisa útil que você leva desta conversa?”

Guia de postura profissional

O que transmite segurança

- Explicar o funcionamento sem pressa.
- Assumir limites técnicos quando necessário.
- Usar supervisão como parte do cuidado, não como sinal de incompetência.
- Registrar sessões com objetividade.
- Manter combinados claros sobre contato, faltas e pagamento.
- Encaminhar quando a demanda ultrapassar sua competência ou estrutura.

Frases úteis

“Essa é uma questão importante. Quero pensar nela com cuidado e, se necessário, vou buscar supervisão para conduzir da forma mais responsável.”

“A terapia não depende de você chegar com tudo organizado. Podemos construir essa compreensão aos poucos.”

“Esse ponto envolve risco/segurança, então vou precisar fazer algumas perguntas mais diretas para cuidar melhor de você.”

Faltas, cobrança e remarcações

Antes de atender

Defina sua política de faltas antes de precisar aplicá-la. Quando a regra aparece apenas depois do problema, tende a gerar desgaste e insegurança.

Situação	Resposta profissional possível
Paciente falta sem aviso	Enviar mensagem breve, acolhedora e objetiva, lembrando a política combinada.
Paciente atrasa pagamento	Retomar combinado financeiro sem tom punitivo ou constrangedor.
Paciente pede remarcações frequentes	Explorar obstáculos reais e revisar viabilidade do horário/ processo.
Paciente quer contato intenso entre sessões	Reafirmar limites e orientar recursos de crise quando necessário.

Clareza não é frieza. Um combinado bem explicado protege o paciente, o profissional e o processo terapêutico.

Atendimento online

Checklist técnico

- Plataforma definida.
- Link enviado com antecedência.
- Internet e áudio testados.
- Ambiente privado.
- Plano para queda de conexão.

Checklist clínico

- Confirmar local onde a pessoa está.
- Checar privacidade.
- Ter contato de emergência quando aplicável.
- Combinar limites de mensagem.
- Conhecer rede de apoio/serviços em caso de risco.

Frase de abertura

“Antes de começarmos, quero confirmar se você está em um ambiente com privacidade e se consegue falar com segurança. Se a conexão cair, combinamos que eu tento retornar pelo mesmo link ou pelo canal combinado.”

Marketing ético básico

Divulgação profissional deve ser informativa, responsável e compatível com as normas da Psicologia. Evite promessas de resultado, sensacionalismo, exposição de casos identificáveis, comparação depreciativa com colegas ou linguagem que explore sofrimento de forma apelativa.

Você pode comunicar

- Formação e áreas de estudo.
- Público atendido.
- Modalidade de atendimento.
- Temas psicoeducativos.
- Como funciona a terapia.
- Orientações de acesso e contato.

Evite

- “Cure sua ansiedade em X sessões”.
- “Agenda lotada garantida”.
- Depoimentos de pacientes.
- Antes e depois clínico.
- Descontos apelativos.
- Conteúdo que gere medo para vender.

Checklist de perfil profissional

Item	OK?
Nome profissional e CRP visíveis	
Público/modalidade descritos com clareza	
CTA humano para contato	
Destaques: atendimento, dúvidas, formação, conteúdos	
Conteúdos educativos sem promessa de cura	

Como explicar terapia sem parecer vendedor

Explicação simples

“A terapia é um espaço de cuidado psicológico em que vamos compreender padrões, emoções, pensamentos, comportamentos e contextos que influenciam seu sofrimento. O objetivo não é dar conselhos prontos, mas construir compreensão, estratégias e mudanças possíveis para sua realidade.”

Para quem pergunta se precisa estar muito mal

“Você não precisa esperar chegar ao limite para buscar terapia. Muitas pessoas procuram atendimento quando percebem que algo na rotina, nas relações, nas emoções ou nas escolhas precisa de mais cuidado.”

Para quem tem medo de julgamento

“Você não precisa chegar com tudo bonito ou organizado. O espaço terapêutico existe justamente para acolher o que ainda está confuso, difícil ou doloroso.”

Plano de 30 dias para começar com mais segurança

Semana	Foco	Ações práticas
1	Estrutura básica	Definir horários, valores, política de faltas, contrato e modelo de evolução.
2	Presença profissional	Organizar bio, destaques, contato, página simples ou link de apresentação.
3	Rotina clínica	Padronizar anamnese, primeira sessão, registros e supervisão.
4	Captação ética	Produzir conteúdos educativos, comunicar agenda com cuidado e fortalecer rede de indicação.

Minha próxima ação profissional

O que preciso organizar esta semana?

Que insegurança preciso levar para supervisão?

Agenda e financeiro

Este kit acompanha uma planilha simples para organizar atendimentos, status de pagamento, faltas, remarcações e resumo financeiro mensal.

Use para acompanhar

- Data e horário da sessão.
- Nome ou código do paciente.
- Modalidade.
- Status: realizada, falta, remarcada.
- Valor, pagamento e observações.

Cuidados

- Evite expor dados sensíveis desnecessários.
- Use códigos ou iniciais quando possível.
- Proteja arquivos com senha e backup seguro.
- Separe organização financeira de evolução clínica.

Encerramento

Começar na clínica pode gerar insegurança, e isso não significa falta de capacidade. Significa que você está entrando em uma prática complexa, humana e cheia de responsabilidade.

Use este kit como chão inicial: uma estrutura para reduzir imprevisto, organizar decisões e lembrar que o desenvolvimento profissional acontece com estudo, supervisão, experiência e cuidado ético constante.

Você não precisa parecer seguro o tempo todo. Precisa construir segurança de forma responsável.

PARTE EXTRA

Modelos prontos para situações reais

Um conjunto de scripts, checklists e folhas de apoio para reduzir o improviso nos primeiros meses de clínica.

Primeiro contato pelo WhatsApp

O primeiro contato não precisa virar atendimento por mensagem. Ele deve acolher, orientar e levar a pessoa para um formato adequado de avaliação.

Mensagem inicial acolhedora

“Olá, tudo bem? Obrigado por entrar em contato. Eu realizo atendimentos psicológicos em formato _____. Para entender se consigo te atender com responsabilidade, posso te fazer algumas perguntas breves sobre o que você está buscando?”

Quando a pessoa conta muita coisa por mensagem

“Entendo que isso esteja sendo importante e agradeço por confiar em me contar. Para cuidarmos disso com mais segurança e privacidade, o ideal é conversarmos em sessão. Por mensagem eu consigo apenas alinhar informações de agendamento e funcionamento.”

Quando há urgência ou risco

“Pelo que você descreveu, parece importante buscar ajuda imediata. Se houver risco de você se machucar ou não conseguir se manter em segurança, procure um serviço de emergência da sua região ou acione alguém de confiança para ficar com você agora.”

Triagem breve sem transformar em sessão

Pergunta	Objetivo
Você busca atendimento para você ou para outra pessoa?	Identificar quem será atendido.
Qual é o principal motivo da busca neste momento?	Entender demanda geral.
Você já faz acompanhamento psicológico ou psiquiátrico?	Mapear cuidado atual.
Há alguma situação de urgência, risco ou crise agora?	Checar necessidade de encaminhamento imediato.
Você prefere atendimento online ou presencial?	Avaliar modalidade.
Tem disponibilidade em quais períodos?	Organizar agenda sem troca excessiva de mensagens.

Triagem não é diagnóstico. É uma conversa breve para entender se o atendimento é possível, seguro e adequado.

Checklist de risco na primeira sessão

Use com cuidado e supervisão

Quando aparecer desesperança intensa, ideação suicida, automutilação, violência, abuso, negligência, uso grave de substâncias ou risco de terceiros, investigue de forma direta e responsável. Perguntar sobre risco não “coloca ideia” na cabeça da pessoa; pode abrir caminho para proteção.

Ponto a avaliar	Perguntas possíveis
Ideação de morte	Você tem pensado em morrer, desaparecer ou não continuar vivendo?
Plano	Você chegou a pensar em como faria isso?
Meios	Você tem acesso ao meio que pensou usar?
Intenção	De 0 a 10, quão perto você sente que está de agir?
Proteção	O que ou quem te ajuda a se manter seguro agora?
Rede	Quem pode ser acionado hoje se o risco aumentar?

Fluxo básico de manejo de risco

1. Reduzir isolamento

Identifique alguém de confiança que possa ficar com a pessoa ou acompanhá-la até atendimento.

2. Remover meios

Quando aplicável, oriente redução de acesso a meios de autoagressão com apoio de rede.

3. Acionar cuidado

Encaminhe para emergência, psiquiatria, serviço de saúde ou rede local quando houver risco.

4. Registrar

Registre avaliação, orientações, encaminhamentos, contatos e decisões tomadas.

Plano de segurança simples

Sinais de alerta:

Pessoas/serviços que posso acionar:

Ações para as próximas horas:

Documentos: o que é o quê

Documento	Para que serve	Cuidado
Contrato terapêutico	Organiza funcionamento, valores, faltas e limites.	Não substitui orientação jurídica quando necessária.
Termo de consentimento	Informa condições, sigilo, registros e modalidade.	Deve ser claro e compreensível.
Anamnese	Coleta dados iniciais e contexto clínico.	Não precisa virar interrogatório.
Evolução	Registra processo e intervenções.	Evite julgamentos e informações desnecessárias.
Plano terapêutico	Organiza objetivos, hipóteses e caminhos.	É provisório e deve ser revisado.

Prontuário: registro com segurança

Registre

- Data e modalidade da sessão.
- Demanda trabalhada.
- Intervenções relevantes.
- Resposta do paciente.
- Risco, encaminhamentos e orientações quando houver.
- Plano para continuidade.

Evite

- Frases moralizantes.
- Opiniões pessoais sem função clínica.
- Excesso de detalhes íntimos sem necessidade técnica.
- Exposição de terceiros sem relevância.
- Promessas de resultado.

Um bom registro é claro, suficiente e profissional. Ele protege o processo, não precisa narrar tudo.

Modelo de evolução para 12 sessões

Sessão	Tema central	Intervenção	Plano
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Plano terapêutico: exemplo preenchido

Campo	Exemplo
Demanda	Ansiedade em situações de avaliação e evitação de apresentações.
Hipótese inicial	Medo de julgamento, catastrofização e esquiva mantendo ciclo ansioso.
Objetivo geral	Aumentar repertório de enfrentamento e reduzir evitação.
Objetivos específicos	Mapear gatilhos, identificar pensamentos automáticos, construir exposição gradual, treinar autorregulação.
Indicadores	Menos faltas, maior permanência em situações, melhor manejo fisiológico.
Revisão	A cada 4 a 6 sessões ou diante de mudança significativa.

Como lidar com insegurança profissional

Pensamento comum

“Se eu não souber responder tudo, vou parecer incompetente.”

Resposta mais realista

Você não precisa ter respostas prontas. Precisa sustentar uma postura ética, investigar com cuidado e buscar supervisão.

Pensamento comum

“O paciente vai perceber que sou recém-formado.”

Resposta mais realista

Experiência importa, mas clareza, presença, organização e responsabilidade também transmitem segurança.

Mapa da minha insegurança

O que mais me dá medo nos primeiros atendimentos?

O que é falta de experiência e o que é falta de estrutura?

O que preciso levar para supervisão?

Supervisão: como aproveitar melhor

Supervisão não é lugar para provar que você sabe. É lugar para pensar com mais segurança sobre o que ainda está confuso.

Leve para supervisão	Exemplos
Dúvidas de condução	“Não sei se aprofundo ou estabilizo primeiro.”
Risco	“Apareceram falas de morte e quero revisar manejo.”
Vínculo	“Sinto que o paciente evita emoção e eu fico perdido.”
Hipótese	“Tenho dúvidas sobre o que mantém o problema.”
Limites	“O paciente manda muitas mensagens entre sessões.”

Mensagens prontas para situações comuns

Confirmação de sessão

“Olá! Passando para confirmar nossa sessão de amanhã, às _____. Qualquer imprevisto, me avise dentro do prazo combinado para remarcações.”

Falta sem aviso

“Olá. Notei que você não conseguiu comparecer à sessão de hoje. Espero que esteja tudo bem. Conforme nosso combinado, a sessão será considerada como falta. Podemos alinhar a continuidade do atendimento?”

Pedido de encaixe urgente sem risco imediato

“Entendo que esteja difícil. No momento não tenho horário extra disponível antes da nossa sessão, mas podemos priorizar esse tema no próximo encontro. Se houver risco ou urgência, procure atendimento imediato na sua rede local.”

Encerramento/pausa

“Podemos conversar sobre essa pausa com cuidado, para entendermos se é uma interrupção, encerramento, encaminhamento ou ajuste necessário no processo.”

Conteúdo ético para Instagram

O objetivo do conteúdo profissional não é expor casos nem prometer resultado. É educar, orientar e facilitar que as pessoas entendam seu trabalho.

Tipo	Exemplo de tema
Educativo	“Ansiedade não é apenas pensamento: o corpo também entra em alerta.”
Quebra de mito	“Terapia não é só desabafo, mas também construção de recursos.”
Processo	“O que acontece na primeira sessão de psicoterapia?”
Humanização	“Você não precisa chegar sabendo explicar tudo.”
Orientação	“Quando buscar ajuda psicológica?”

Mini calendário de 30 dias de conteúdo

Conteúdo ético para criar presença sem parecer vendedor

Este calendário foi pensado para psicólogos em início de carreira que precisam aparecer com clareza, mas sem promessas, sensacionalismo, exposição de sofrimento ou linguagem apelativa. A ideia é construir confiança por educação, acolhimento, posicionamento e explicação do processo terapêutico.

Você pode adaptar os temas ao seu nicho: ansiedade, autoestima, terapia infantil, orientação parental, relacionamentos, TCC, neurodivergência, carreira, saúde emocional no trabalho ou outro campo de atuação.

Estrutura sugerida: 3 posts por semana + stories simples nos outros dias. Se estiver começando, faça menos, mas mantenha consistência.

Calendário - dias 1 a 10

Dia	Formato	Tema	Ideia de abordagem	CTA ético
1	Post fixo	Quem sou e como trabalho	Apresente formação, abordagem, público atendido e forma de atendimento sem exageros.	"Para entender melhor meu trabalho, veja os destaques do perfil."
2	Story	Caixa de dúvidas	Abra uma caixinha sobre terapia, primeira sessão ou ansiedade.	"Envie uma dúvida geral sobre psicoterapia."
3	Carrossel	O que é terapia?	Explique que terapia não é conselho, julgamento ou conversa aleatória.	"Salve para lembrar quando pensar em começar terapia."
4	Story	Bastidor profissional	Mostre agenda, livros, organização de estudos ou preparação de sessão sem expor pacientes.	"Por trás de uma sessão existe preparo e responsabilidade."
5	Reels curto	Primeira sessão	Explique o que geralmente acontece no primeiro atendimento.	"Compartilhe com alguém que tem medo de começar."
6	Story	Enquete	"Você já fez terapia?" "Tem medo da primeira sessão?"	"Vou responder dúvidas gerais nos próximos stories."
7	Post texto	Sigilo	Explique de forma simples o sigilo profissional e seus limites em situações de risco.	"Esse é um dos pilares do atendimento psicológico."
8	Carrossel	Ansiedade no corpo	Fale de sintomas físicos comuns sem diagnóstico fechado.	"Se isso traz prejuízo, procure avaliação profissional."
9	Story	Mito ou verdade	"Terapia é só para quem está em crise?"	"Terapia também pode ser prevenção e desenvolvimento."
10	Reels	Autocobrança	Use um exemplo cotidiano: a mente que transforma cansaço em culpa.	"Salve para rever em dias de cobrança."

Calendário - dias 11 a 20

Dia	Formato	Tema	Ideia de abordagem	CTA ético
11	Story	Rotina emocional	Pergunte qual horário do dia costuma ser mais difícil.	“Observe padrões antes de se julgar.”
12	Carrossel	Como saber se preciso de terapia?	Liste sinais: prejuízo, repetição de padrões, sofrimento persistente, dificuldade de lidar sozinho.	“Use como reflexão, não como autodiagnóstico.”
13	Story	Agenda com cuidado	Comunique horários disponíveis sem promessa de resultado.	“Atendimentos online/ presenciais. Informações pelo link da bio.”
14	Post educativo	Pensamento não é fato	Explique pensamentos automáticos com exemplo simples.	“Na terapia, aprendemos a observar esses padrões.”
15	Reels	Procrastinação	Diferencie preguiça, medo, perfeccionismo, cansaço e falta de clareza.	“Compartilhe com alguém que se cobra demais.”
16	Story	Pergunta interativa	“O que mais te trava: medo de errar, cansaço ou excesso de cobrança?”	“Vou transformar as respostas em conteúdo educativo.”
17	Carrossel	Limites	Explique que limite não é agressividade, é clareza sobre disponibilidade e necessidade.	“Salve para lembrar antes de dizer sim no automático.”
18	Story	Indicação de leitura	Indique um tema ou conceito de forma acessível.	“Conteúdo educativo não substitui acompanhamento.”
19	Post texto	O que a terapia não é	Não é julgamento, fórmula pronta, amizade paga, conselho simplista ou promessa de cura.	“Terapia é processo, vínculo e responsabilidade técnica.”
20	Reels	Como funciona atendimento online	Explique privacidade, ambiente, link, duração e cuidados.	“Dúvidas sobre modalidade podem ser enviadas pelo contato profissional.”

Calendário - dias 21 a 30

Dia	Formato	Tema	Ideia de abordagem	CTA ético
21	Story	Caixa de dúvidas	Abra dúvidas sobre primeira sessão, sigilo, ansiedade ou rotina.	“Responderei de forma geral e educativa.”
22	Carrossel	Autoestima realista	Fale de autoestima como relação consigo, não como se achar incrível todos os dias.	“Salve para rever quando estiver se comparando.”
23	Story	Bastidor ético	Mostre estudos, organização ou preparação de materiais sem romantizar excesso de trabalho.	“Atualização também faz parte do cuidado.”
24	Post educativo	Quando pedir ajuda	Explique sinais de alerta e importância de rede/profissional em casos de risco.	“Em risco imediato, procure serviço de urgência.”
25	Reels	Relações e padrões repetidos	Mostre como padrões relacionais podem se repetir sem a pessoa perceber.	“Terapia ajuda a observar padrões com mais clareza.”
26	Story	Enquete	“Você costuma se cobrar mais do que acolher?”	“Amanhã vou falar sobre autocompaixão.”
27	Carrossel	Autocompaixão	Diferencie autocompaixão de passar pano ou abandonar responsabilidade.	“Compartilhe com alguém que se trata com dureza.”
28	Story	Aviso de agenda	Comunique disponibilidade de horários com sobriedade.	“Para informações sobre atendimento, use o link da bio.”
29	Post fixo	Como começar terapia comigo	Explique passo a passo: contato, triagem inicial, sessão, contrato, continuidade.	“As informações de atendimento estão no link da bio.”
30	Reels ou carrossel	Fechamento do mês	Reforce uma mensagem central: cuidar da saúde mental não precisa esperar colapso.	“Salve este perfil para acompanhar conteúdos de psicologia.”

Banco de ideias extras para conteúdo

Conteúdos de educação

- O que é ansiedade?
- Diferença entre emoção e comportamento.
- Como pensamentos automáticos aparecem.
- Por que evitar tudo aumenta o medo.
- O que é regulação emocional.

Conteúdos de confiança

- Como funciona a primeira sessão.
- Como o sigilo é explicado.
- O que você pode falar na terapia.
- Quando o psicólogo encaminha.
- Como funciona atendimento online.

Conteúdos de identificação

- Quando descansar dá culpa.
- A mente que transforma tudo em urgência.
- O medo de decepcionar os outros.
- Quando dizer sim vira autoabandono.
- O cansaço de parecer bem.

Cuidados éticos

- Não prometa cura, agenda cheia ou resultado garantido.
- Não exponha pacientes, histórias clínicas ou prints.
- Não use dor extrema como isca emocional.
- Evite linguagem de superioridade profissional.
- Prefira educação, clareza e convite responsável.

Meu calendário adaptado

Meu público principal:

Três temas que quero trabalhar este mês:

Meu CTA padrão, humano e ético:

Checklist final antes de atender

Área	Item	OK?
Ética	Tenho clareza sobre sigilo, limites e encaminhamento.	
Estrutura	Tenho contrato, termo, anamnese e evolução.	
Financeiro	Defini valor, pagamento, faltas e remarcações.	
Clínica	Tenho supervisão ou rede para discutir casos.	
Online	Tenho link, plano de queda e privacidade.	
Marketing	Meu perfil explica meu trabalho sem promessas.	
Agenda	Tenho controle de horários e pagamentos.	